

Custodia, archivo, préstamo y entrega de copias

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Permitir acceso legítimo sin perder trazabilidad, reserva o integridad del expediente.

2. Alcance y condiciones de uso

Documentos físicos, electrónicos, consentimientos y anexos. El préstamo no se confunde con entrega definitiva de originales.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Autor de la atención	Registrar de manera oportuna, íntegra y autenticada.
Custodio	Controlar acceso, conservación, entrega y recuperación.
Apoyo administrativo	Acceder solo a datos necesarios según permiso.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Definir custodio y ubicación del archivo, inventario y acceso por rol

Definir custodio y ubicación del archivo, inventario y acceso por rol. Mantener expediente ordenado y protegido, sin carpetas abiertas en recepción.

2. Recibir solicitud con identidad, legitimación y finalidad

Recibir solicitud con identidad, legitimación y finalidad. Verificar titular, representante o autoridad y fundamento antes de divulgar; no entregar por ser familiar, empleador o asegurador sin base válida.

3. Identificar qué documentos se autorizan y excluir información de terceros no procedente

Identificar qué documentos se autorizan y excluir información de terceros no procedente. Elaborar copia íntegra de lo solicitado conforme a derecho, sin modificar notas originales.

4. Registrar préstamo o entrega con fecha, documentos, medio seguro, destinatario y soporte

Registrar préstamo o entrega con fecha, documentos, medio seguro, destinatario y soporte. En préstamo interno fijar devolución y comprobar integridad.

5. Controlar transferencias entre archivos y conservación

Controlar transferencias entre archivos y conservación. Ante pérdida o acceso no autorizado preservar evidencias, evaluar impacto y activar medidas y comunicaciones legales pertinentes.

6. Al cierre o cambio de custodio hacer inventario y acta de entrega auténtica, comunicar can

Al cierre o cambio de custodio hacer inventario y acta de entrega auténtica, comunicar canal y mantener continuidad de acceso. No eliminar historia por dejar de atender al paciente.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Legitimación comprobada.

Registro por préstamo o entrega.

Inventario y conservación intactos.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.6 y 11.3.1.27-28: historia y registros; Resoluciones 1995/1999, 839/2017, Ley 1581/2012 y consentimiento conforme a Ley 528/1999 y reglas particulares.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Solicitud y fecha	
Titular o representante	
Legitimación y fundamento	
Documentos autorizados	
Medio y destinatario	
Entrega y soporte	
Préstamo y devolución	
Integridad	
Custodio	
Incidente	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Historia clínica

Resolución 1995 de 1999, artículos 3-5 y 11-14: registro, autoría, anexos, custodia y acceso. Resolución 839 de 2017, artículo 3: retención general mínima de 15 años y reglas especiales; el archivo no se elimina automáticamente al vencer un plazo.

<https://minsalud.gov.co/ihce/Paginas/Normatividad.aspx>

Datos sensibles

Ley 1581 de 2012, artículos 4-6, 8-12 y 17-18; Decreto 1074 de 2015, reglas de tratamiento. Información de salud y finalidades opcionales requieren análisis de base jurídica, autorización cuando exigible y seguridad.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576